



HIGIENE DE SONO • EDIÇÃO I

ACHAS QUE TENS INSÓNIA. NÃO TENS.

Um protocolo clínico de reset circadiano para mulheres em perimenopausa. Os três erros que confundem higiene de sono com insónia — e o que fazer em seu lugar. Fundamentado em Huberman Lab, Matthew Walker e Satchin Panda; sintetizado a partir de mais de 200 consultas reais.

18
PÁGINAS

4 SEMANAS DE
PROTOCOLO

AUTO-AVALIAÇÃO • TRACKER •
FAQ

Catarina Veiga

MEDICINA FUNCIONAL INTEGRATIVA

Edição I • 2026
uso individual

— RECONHECIMENTO

ESTAS FRASES NÃO SÃO TUAS. PERTENCEM A CENTENAS.

Antes de explicar o que se passa, ouve-te primeiro. Estas são frases reais, recolhidas em consulta clínica nos últimos dois anos — anonimizadas, exactas.

“

Sono não reparador. Raramente acordo descansado. Este problema persiste há vários anos, mas agora está a agravar-se.

VERBATIM • 40-44 • ARQUIVO CLÍNICO

“

O sono sem qualidade.

VERBATIM • 45-49 • ARQUIVO CLÍNICO

“

Sono incerto; alimentação pouco adaptada à fase da perimenopausa; cansaço.

VERBATIM • 45-49 • ARQUIVO CLÍNICO

“

Estou sempre em estado de alerta. Acordo às 3h com pensamentos catastróficos.

VERBATIM • 50-54 • ARQUIVO CLÍNICO

Se te reconheceste em alguma destas, lê com atenção. O que vem a seguir não é mais um truque para "dormires melhor". É um **protocolo clínico** que distingue o que a maioria das mulheres em perimenopausa chama insónia daquilo que, na investigação atual, **quase sempre** é higiene de sono inexistente sobre um sistema que deixou de tolerar essa ausência.

A diferença é importante. Insónia clínica e higiene de sono inexistente não se tratam da mesma maneira — e tentar tratar uma como se fosse a outra é o que mantém milhões de mulheres em ciclos de medicação, suplementação e frustração que não vão a lado nenhum.

O TEU CORPO TRABALHA EM RITMO. NÃO EM VONTADE.

O ritmo circadiano é o relógio interno de 24 horas que controla **centenas de processos biológicos** em paralelo: produção hormonal, temperatura corporal, digestão, função imunitária, performance cognitiva, libertação de cortisol e melatonina. Não é uma "preferência". É uma máquina afinada por milhões de anos de evolução, sob luz solar.

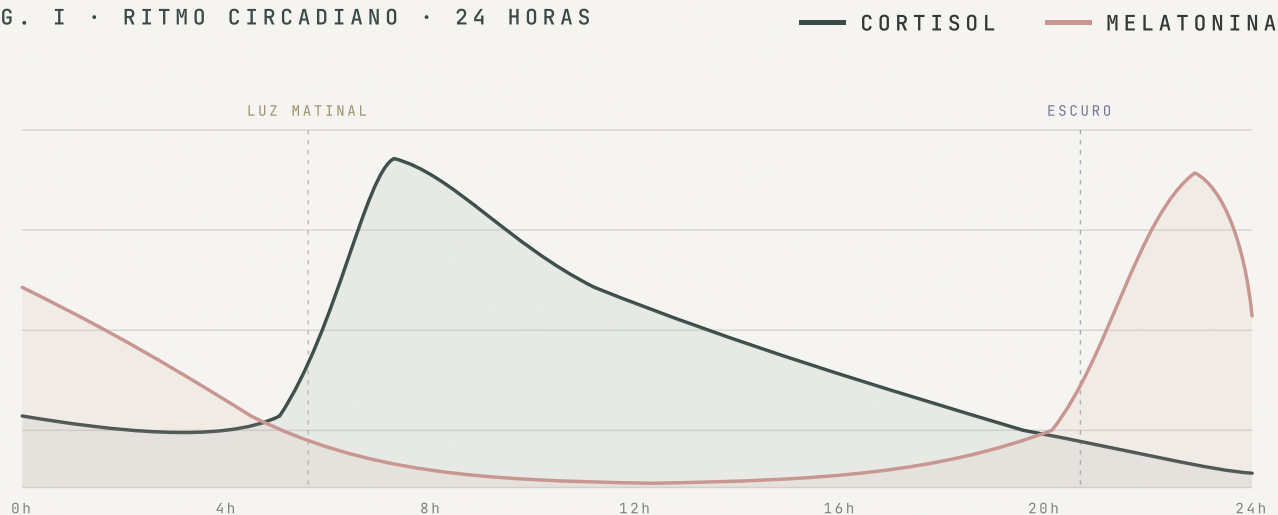
A MÁQUINA POR TRÁS

No centro do sistema está o *núcleo supraquiasmático* (SCN) — uma estrutura de cerca de **100.000** neurónios localizada acima do quiasma óptico, onde os nervos ópticos se cruzam. O SCN é o "relógio mestre" do corpo. Tudo o resto sincroniza com ele.

A retina contém entre **2.000 e 5.000** células ganglionares especializadas, fotossensíveis, que expressam uma molécula chamada *melanopsina*. Estas células não servem para "ver" — servem exclusivamente para **signalizar ao SCN que parte do dia é**. Detectam luz no espectro azul e enviam essa informação directamente ao relógio mestre.

— MECANISMO DESCRITO POR SATCHIN PANDA (SALK INSTITUTE)

FIG. I • RITMO CIRCADIANO • 24 HORAS



~1000

LUX NECESSÁRIOS PARA
ACTIVAR MELANOPSINA

100k

NEURÓNIOS NO NÚCLEO
SUPRAQUIASMÁTICO

2-5k

CÉLULAS GANGLIONARES
COM MELANOPSINA

Em perimenopausa, esta sensibilidade **umenta**. As "almofadas hormonais" — sobretudo progesterona — que antes amorteciam pequenas desorganizações deixam de estar consistentemente presentes. O que antes era tolerável passa a ser sintoma.

— O QUE O SONO FAZ

NÃO DORMES PARA DESCANSAR. DORMES PARA RECONSTRUIR.

A ideia de que o sono é "tempo perdido" — ou descanso passivo — desactualizou-se há décadas. Durante o sono, o corpo executa **tarefas que só podem ser feitas quando estás inconsciente**. Quando cortas sono, não cortas descanso. Cortas trabalho biológico activo.

NREM (SONO PROFUNDO) — A PRIMEIRA METADE DA NOITE

Durante o sono NREM (sobretudo nas **primeiras 3-4 horas**), o sistema glinfático abre canais entre as células do cérebro e *limpa metabolitos*, incluindo placa beta-amiloide associada a doença neurodegenerativa. A hormona de crescimento é libertada em picos. O sistema imunitário regenera. A memória factual consolida-se do hipocampo para o córtex.

REM — A SEGUNDA METADE DA NOITE

Nas **últimas 3-4 horas**, o sono entra em ciclos cada vez mais longos de REM. Aqui acontece a regulação emocional, a integração de aprendizagem, a consolidação de memória procedimental, e a criatividade. Cortar a manhã (acordar 1-2h mais cedo do que precisas) **sacrifica desproporcionalmente** esta fase.

— MATTHEW WALKER, *WHY WE SLEEP*

QUANDO DORMES 6H EM VEZ DE 8H, PERDES 25% DO TEMPO TOTAL — MAS 60-90% DO REM

A matemática é a parte que a maioria não conhece. As fases NREM e REM não se distribuem uniformemente pela noite. O REM concentra-se nas **últimas horas**. Cortar 2 horas no fim da noite não corta 2 horas de "sono qualquer" — corta as duas horas *mais críticas para a função cognitiva e emocional* do dia seguinte.

Isto explica por que, ao fim de 2-3 semanas com 6h de sono, a função cognitiva mede equivalente a um teste de álcool no sangue acima do limite legal — mesmo quando a pessoa subjectivamente sente que "se adaptou".

A privação de sono crónica *degrada-te sem te avisar*.

DEITAS-TE QUANDO TENS SONO. NÃO QUANDO DEVES.

Hoje vais para a cama às 23h. Amanhã à meia-noite e meia. Na sexta às duas da manhã. A maioria das pessoas chama a isto "vida normal" — é o que acontece quando se vai dormir quando se está com sono.

Do ponto de vista do relógio interno, isto é *jet lag social diário*: o equivalente a apanhar um voo transatlântico todas as noites. O SCN nunca consegue estabelecer um padrão. O cortisol matinal não sabe quando subir. A melatonina vespertina não sabe quando começar a ser libertada. E o resultado é o que sentes: dormes mal, acordas pior, e culpas a tua biologia por algo que é, na verdade, um problema de **sinal inconsistente**.

A CORREÇÃO

A correção não passa por **ter sono à hora certa**. Passa por **ir para a cama à hora certa, com sono ou sem**. O corpo só aprende quando é dia ou noite se os horários forem repetidos — e a janela de aprendizagem do SCN é de aproximadamente **3-4 semanas** de consistência rigorosa.

Importante: a regra aplica-se aos **7 dias da semana**. "Recuperar sono ao fim de semana" não funciona — só prolonga o jet lag social. Cada hora que vais para a cama mais tarde ao fim de semana custa 2-3 dias de reset no início da semana seguinte.

VALIDAÇÃO CLÍNICA • CATARINA

JANELA DE HORÁRIO • CONTEXTO INDIVIDUAL

A hora exacta depende do teu cronotipo (matutino vs vespertino), das tuas obrigações, e da fase de vida. Para a maioria das mulheres em perimenopausa, uma janela entre **22h00 e 23h30** funciona — mas o que importa é **fixar uma hora e respeitá-la**, não qual hora é.

A hora a que te deitas *ensina* o teu corpo quando deve ter sono.

CAMA DEIXOU DE SIGNIFICAR SONO.

Vês televisão na cama. Trabalhas na cama. Respondeste ao email na cama. Quando vais finalmente dormir, o teu cérebro não sabe o que se está a passar — porque para ele a cama tornou-se um sítio de **activação**, não de **descanso**. Espera estímulo, não desligar.

Em terapia comportamental para insónia (CBT-i, o tratamento de primeira linha recomendado pela *American College of Physicians* antes de qualquer medicação), esta intervenção chama-se **controlo de estímulo** e tem uma das evidências mais sólidas em ciência do sono.

A REGRA DOS 20 MINUTOS

Se ao fim de aproximadamente **20 minutos** deitada não adormeceste — ou se acordares a meio da noite e não voltares a adormecer — **sai da cama**. Vai a outra divisão com luz baixa. Lê algo aborrecido (não telemóvel). Regressa quando o corpo te der sinal real de sono. Repete quantas vezes for necessário.

O objectivo é restaurar a *associação automática* entre estar deitada e adormecer — uma resposta condicionada que se perdeu com os anos de uso múltiplo do espaço. Demora **2 a 4 semanas** a reinstalar. Não exige medicação, não exige suplemento. Exige **regra**.

CAMA = SONO E SEXO. MAIS NADA.

Esta é a regra exacta usada em CBT-i: cama exclusiva para sono e intimidade sexual. Sem ecrã. Sem trabalho. Sem ler durante mais de 20 minutos se estiveres com tensão.

VALIDAÇÃO CLÍNICA • CATARINA

EXCEPÇÕES • CO-MORBILIDADE • REFINAMENTO

Para mulheres com co-morbilidades (ansiedade clínica, depressão, apneia do sono não diagnosticada), esta intervenção precisa de adaptação. Não é universal nesta forma rígida — mas o princípio mantém-se: a cama precisa de ser ressignificada como sítio exclusivo de sono.

NÃO APANHAS LUZ SOLAR NAS PRIMEIRAS HORAS.

Sais de casa às 8h directamente do quarto para o carro, do carro para o escritório. Não vês o céu antes das 12h. À noite, ficas exposta a luz forte de écrãs e de tectos até momentos antes de te deitares. Para o teu cérebro, isto é uma **ordem hormonal invertida**: pouca luz quando devia ser muita; muita luz quando devia ser pouca.

PORQUE É QUE A LUZ DA CASA NÃO CHEGA

A melanopsina é um fotorreceptor *pouco sensível* por design — protege-te de o teu relógio ser acidentalmente reiniciado pela luz da lua. Para activar realmente o sinal de "manhã", precisa de aproximadamente **1.000 lux** sustentados durante vários minutos. A intensidade ao ar livre — mesmo em dia nublado — é de **10.000 a 100.000 lux**. A iluminação típica de uma casa é de **100 a 300 lux**. A diferença não é "um pouco". É **uma a duas ordens de grandeza**.

— HUBERMAN LAB, MASTER YOUR SLEEP

100k

LUX • SOL DIRETO
AO MEIO-DIA

10k

LUX • AR LIVRE
DIA NUBLADO

~300

LUX • ILUMINAÇÃO
TÍPICA DE CASA

Sem luz forte de manhã, o sinal nunca chega. O cortisol matinal não sobe a tempo. O ritmo nunca arranca. E à noite acontece o oposto: o teu telemóvel a 30cm dos olhos manda um sinal de "ainda é dia" durante horas depois de ter anoitecido — e a melatonina, que devia começar a libertar-se cerca de 90 minutos antes da hora de deitar, simplesmente não vem.

A CORREÇÃO: 10-20 MINUTOS ANTES DAS 9H

10 a 20 minutos de exposição directa à luz natural **antes das 9h da manhã** reorganizam o sistema. Não precisa de ser sol — basta estar ao ar livre. Café no terraço, varanda, caminhada curta. **Sem óculos de sol** nesse momento — a melanopsina precisa do espectro completo. Vidro do carro/janela reduz a intensidade em até 50%.

À noite, o oposto: baixar a intensidade da iluminação da casa pelo menos **90 minutos** antes de te deitares. Lâmpadas de teto desligadas. Candeeiros baixos. Ecrãs em modo noturno ou desligados. Esta é a outra metade da equação.

Luz forte de manhã. Pouca luz à noite. O resto segue.

AS TRÊS CORREÇÕES, NA ORDEM CERTA.

01 HORA FIXA DE DEITAR

Escolhe uma hora entre **22h00 e 23h30** e vai para a cama a essa hora todos os dias — incluindo fins-de-semana, com sono ou sem. Permanece na cama 8 horas. Se ainda não tens sono ao fim de 20 minutos, sai e regressa quando tiveres. Treinar o corpo é exactamente isto. Janela de adaptação: 3-4 semanas.

02 LUZ NATURAL ANTES DAS 9H

10 a 20 minutos ao ar livre logo de manhã. Café no terraço, caminhada curta, varanda. **Sem óculos de sol** nesse momento. Se chove ou está cinzento, faz na mesma — 10.000 lux ao ar livre em dia nublado vs. 300 lux dentro de casa. A diferença mantém-se.

03 CAMA = SONO

Acaba o uso múltiplo da cama. Sem ecrã. Sem trabalho. Sem ler durante mais de 20 minutos se estiveres com tensão. Se estás acordada às 3h com pensamentos catastróficos, sai da cama, vai a outra divisão com luz baixa, regressa quando o corpo se acalmar. Repete tantas vezes for necessário.

04 JANELA ALIMENTAR FECHADA ANTES DA HORA DE DEITAR

Última refeição **2 a 3 horas** antes de te deitares. Comer tarde sobe a temperatura corporal, atrasa a libertação de melatonina, e fragmenta o sono profundo. A janela alimentar do dia deve fechar com a luz, não horas depois.

05 CAFEÍNA CORTE ÀS 14H

Meia-vida da cafeína: 5-6 horas. Um café às 16h tem ainda 50% activo às 22h. A maioria das pessoas não sente o efeito da cafeína no sono — mas ele está lá, sobretudo no sono profundo da primeira metade da noite.

06 TEMPERATURA AMBIENTE BAIXA

Quarto fresco: 17-19°C. A queda da temperatura corporal central é um dos sinais primários de adormecer. Quarto demasiado quente bloqueia esse sinal.

VALIDAÇÃO CLÍNICA • CATARINA

MELATONINA • SUPLEMENTAÇÃO • MEDICAÇÃO

Suplementos (melatonina **0.3-1mg**, magnésio glicinato **200-400mg**, l-teanina **100-200mg**) podem ter lugar, mas só funcionam quando a higiene de base está instalada. Antes disso, mascaram um problema estrutural e perdem efeito em semanas. A melatonina, em particular, é mais eficaz como *senal de horário* (tomada à mesma hora todos os dias) do que como sedativo — doses farmacológicas (3-10mg) são contra-produtivas para esse efeito.

RESET NÃO É INSTANTÂNEO. É CONSISTENTE.

O corpo precisa de tempo para reaprender. Estes são os marcos clínicos que tipicamente observo, com adesão estrita ao protocolo.

DIA 1 - 7

Adesão é o desafio principal. O corpo resiste, sobretudo nas primeiras 4-5 noites — pode **parecer que estás a dormir pior**. É esperado. Não desistas. Importante: nenhum suplemento ajuda nesta fase, porque o sistema ainda não tem ritmo para responder.

SEMANA 2 - 3

O cortisol matinal começa a subir mais cedo e mais alto. Acordares espontâneos antes do alarme. A latência (tempo até adormecer) começa a baixar para 15-25 minutos. Os despertares de madrugada começam a ser menos frequentes.

SEMANA 4 - 6

Padrão estabelecido. Tens fome de manhã (sinal forte de cortisol matinal correto). Cansaço aparece à mesma hora todos os dias, 2-3h antes de deitar. Sono mais profundo. Se chegaste aqui sem grandes melhorias, é **aqui** que faz sentido investigar insónia real, apneia, hipersensibilidade hormonal periovulatória ou outra causa subjacente.

MÊS 3+

Suplementação (se necessária) tem agora terreno para actuar. Análises hormonais e adrenais (cortisol manhã, DHEA-S, eixo HPA, ritmo cortisol 4 amostras) podem ser interpretadas sem o ruído da desorganização circadiana.

MANUTENÇÃO

O ritmo, uma vez instalado, é resiliente a perturbações pontuais (uma noite, uma viagem, um stress agudo). Mas degrada se voltas a horários variáveis durante mais de 5-7 dias seguidos. **Não é uma cura. É uma prática.**

VALIDAÇÃO CLÍNICA · CATARINA

QUANDO SUSPEITAR DE INSÓNIA REAL

Após **4 a 6 semanas** de protocolo estrito, se continuas a ter latência longa (>30 min), múltiplos despertares por noite, ou sono não reparador apesar de 7-8h, isso já não se chama higiene — chama-se insónia clínica e justifica investigação complementar (apneia, hipotireoidismo, ansiedade, hipersensibilidade periovulatória, deficiência ferro/ferritina). O protocolo é a **linha de base** que torna possível distinguir uma da outra. Sem ele, é impossível saber.

ANTES DE COMEÇAR, MEDE ONDE ESTÁS.

Responde com sinceridade. Vais comparar com a mesma lista ao fim de 4 semanas — sem ponto zero, não tens forma de saber o que mudou.

01	A hora a que me deito varia mais de 1h durante a semana	S	N
02	Demoro mais de 20 minutos a adormecer (latência)	S	N
03	Acordo no meio da noite e não volto a adormecer com facilidade	S	N
04	Uso o telemóvel/tablet/TV na cama	S	N
05	Estou exposta a luz solar directa nos primeiros 60 minutos depois de acordar	S	N
06	Como ou bebo (café, vinho, snacks) menos de 3h antes de deitar	S	N
07	Bebo café/chá com cafeína depois das 14h	S	N
08	Acordo descansada na maioria das manhãs	S	N
09	Sinto-me em alerta constante / com pensamentos catastróficos ao acordar	S	N
10	Já tomei melatonina, magnésio ou outro suplemento de sono sem melhoria sustentada	S	N

Leitura: 4 ou mais "Sim" nas perguntas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 — e/ou "Não" na 5 e 8 — indica higiene de sono inexistente. **O problema quase certamente não é insónia clínica.** Começa o protocolo.

Reservas: se respondeste "Sim" a apenas 1-2 perguntas e tens sono não reparador persistente, suspeita de apneia, hipotireoidismo, hipersensibilidade hormonal periovulatória, ou deficiência ferro/ferritina. Procura investigação clínica complementar.

MEDE O QUE CONSEGUES MEXER.

Sublinha ou marca diariamente. Não tentes mudar tudo de uma vez — segue a ordem do protocolo: começa pelo horário (01), depois adiciona a luz matinal (02), depois cama = cama (03).

INDICADOR • SEMANA 1	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
HORA DE DEITAR							
HORA DE ACORDAR							
LUZ SOLAR <9H (MIN)							
ECRÃ NA CAMA (S/N)							
ÚLTIMA REFEIÇÃO (H)							
LATÊNCIA (MIN ATÉ ADORMECER)							
DESPERTARES NOCTURNOS							
SENSAÇÃO AO ACORDAR (1-5)							

INDICADOR • SEMANA 2	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
HORA DE DEITAR							
HORA DE ACORDAR							
LUZ SOLAR <9H (MIN)							
ECRÃ NA CAMA (S/N)							
ÚLTIMA REFEIÇÃO (H)							
LATÊNCIA (MIN ATÉ ADORMECER)							
DESPERTARES NOCTURNOS							
SENSAÇÃO AO ACORDAR (1-5)							

A DIFERENÇA VAI APARECER AQUI.

Compara a média de "Latência" e "Despertares" da semana 1 com as semanas 3-4. É a tua prova clínica.

INDICADOR • SEMANA 3	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
HORA DE DEITAR							
HORA DE ACORDAR							
LUZ SOLAR <9H (MIN)							
ECRÃ NA CAMA (S/N)							
ÚLTIMA REFEIÇÃO (H)							
LATÊNCIA (MIN ATÉ ADORMECER)							
DESPERTARES NOCTURNOS							
SENSAÇÃO AO ACORDAR (1-5)							

INDICADOR • SEMANA 4	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
HORA DE DEITAR							
HORA DE ACORDAR							
LUZ SOLAR <9H (MIN)							
ECRÃ NA CAMA (S/N)							
ÚLTIMA REFEIÇÃO (H)							
LATÊNCIA (MIN ATÉ ADORMECER)							
DESPERTARES NOCTURNOS							
SENSAÇÃO AO ACORDAR (1-5)							

AS SITUAÇÕES REAIS QUE RECEBO EM CONSULTA.

"SOU MÃE DE FILHOS PEQUENOS. NÃO CONTROLO A MINHA NOITE."

Não controlas os despertares. Controlas tudo o resto. Hora de deitar fixa (sim, mesmo com filho pequeno), luz matinal (mesmo cansada), cama = cama. O protocolo funciona **dentro** da realidade da maternidade, não fora dela. A diferença sentida ao fim de 3 semanas é desproporcionalmente grande — porque o sono que tens passa a estar mais bem estruturado, mesmo que seja menos quantidade.

"TRABALHO POR TURNOS. ISTO APLICA-SE A MIM?"

O princípio aplica-se; a hora muda. O que importa é **fixar uma hora de deitar coerente com o teu turno** e usar luz forte no início do "teu dia" + escuro no fim do "teu turno". Apenas: trabalho por turnos crónico tem um custo metabólico real. Limita os anos. Os teus turnos não devem ser uma vida — devem ser uma fase.

"TOMO MELATONINA HÁ ANOS. POSSO PARAR?"

Sim, e provavelmente deves. Doses farmacológicas (3-10mg) suprimem a produção natural e perdem efeito ao fim de semanas. A estratégia clínica é: reduzir gradualmente para **0.3-1mg** tomada à mesma hora todos os dias (sinal de horário), instalar a higiene de base durante 4 semanas, e depois reavaliar se ainda é necessária.

"E O VINHO À NOITE? FAZ MAL?"

O álcool não é um sedativo — é um **fragmentador do sono**. Adormeces mais depressa, mas a arquitectura do sono fica comprometida durante toda a noite: menos REM, mais despertares na segunda metade, menos sono profundo na primeira. Um copo de vinho com refeição (sentido pelas 19-20h) tem impacto pequeno. Um copo às 22h impacta significativamente o sono.

"POSSO FAZER SESTA?"

Sim, mas com regras: **20-30 minutos**, antes das 15h, em ambiente fresco e escuro. Sestas longas (>1h) ou tardias (após 17h) interferem com a pressão de sono (adenosina) que se acumula durante o dia. **NSDR / Yoga Nidra** (10-20 min, sem adormecer) é alternativa funcional quando o corpo precisa de reset sem comprometer a noite.

O QUE MUDA NESTA FASE.

"ACORDO ÀS 3H COM PALPITAÇÕES / SUORES. FAZ PARTE?"

Faz parte do quadro perimenopausa, sim — mas **não é normal nem deves aceitar** como inevitável. A flutuação de estrogénio nesta fase desregula a regulação térmica (suares nocturnos) e o eixo HPA (despertares com cortisol). A higiene de sono é a base; em paralelo, faz sentido investigar o eixo hormonal (Dutch test, cortisol manhã, perfil estrogénios) com clínica funcional.

"ESTOU EM TRH (TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL). AJUDA NO SONO?"

A progesterona micronizada (Utrogestan, à noite) tem efeito sedativo conhecido e melhora o sono em muitas mulheres em perimenopausa/menopausa. Mas *só funciona bem sobre uma base de higiene de sono instalada*. Se vais começar TRH, instalar este protocolo 2-3 semanas antes amplifica o efeito.

"OS PENSAMENTOS CATASTRÓFICOS ÀS 3H SÃO REAIS OU ANSIEDADE?"

Os dois. O cortisol sobe naturalmente entre as 2 e 4 da manhã (preparação para acordar). Em perimenopausa, esse pico está **desregulado** — sobe mais cedo, mais alto, e o cérebro acorda em modo "ameaça". A combinação cortisol elevado + estrogénio baixo é química perfeita para pensamentos catastróficos. O que sentes é real. **Não é loucura**. É fisiologia. E o protocolo é a primeira intervenção, antes de medicação.

"QUANTO CUSTA NÃO TRATAR ISTO?"

Mulheres com sono cronicamente desregulado em perimenopausa têm risco aumentado documentado de: doença cardiovascular, doença metabólica (resistência à insulina, aumento de gordura visceral), depressão clínica, declínio cognitivo precoce, e — sim — Alzheimer. O sono profundo limpa beta-amilóide. Sem ele consistente, acumula. **Esta fase tem janelas que não voltam**. Aproveita-as.

— WALKER, WHY WE SLEEP • EVIDÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA

VALIDAÇÃO CLÍNICA • CATARINA

LIMITES DO GUIA • QUANDO PROCURAR CONSULTA

Este guia é um **protocolo de base** aplicável a 80% das mulheres em perimenopausa com queixas de sono. Os restantes 20% precisam de investigação clínica individualizada — análises hormonais, perfil adrenal, despiste de apneia, avaliação tiroideia. Se respondeste "Sim" a apenas 1-2 perguntas da auto-avaliação e os sintomas persistem após 4-6 semanas de protocolo estrito, é o teu caso.

O QUE AJUDA. O QUE NÃO COMPRES.

AJUDAM

Cortinas blackout no quarto — diferença mensurável em qualidade de sono profundo. Investimento único, retorno permanente.

Lâmpadas dimmáveis ou Philips Hue / IKEA Trådfri — programar redução automática às 21h. Não exige disciplina, exige sistema.

Apps de filtro noturno — Night Shift (iOS), f.lux (Mac/PC). Reduzem (não eliminam) o impacto da luz azul de ecrã. Mais útil que nada, menos útil que desligar.

Termostato / ventoinha para manter **17-19°C** no quarto.

Despertador analógico / luminoso (Philips SmartSleep / Lumie) — em vez de telemóvel ao lado da cama.

FUNCIONAM EM CASOS ESPECÍFICOS

Lâmpada de fototerapia (10.000 lux) — apenas se tens mesmo zero acesso a luz natural antes das 9h (turnos da manhã, países nórdicos no inverno). Não substitui sol; é último recurso.

Magnésio glicinato (200-400mg ao jantar) — melhor evidência para qualidade subjectiva de sono. Glicinato > óxido > citrato para esta finalidade.

L-teanina (100-200mg, 30-60 min antes de deitar) — promove ondas alfa, relaxamento sem sedação.

Melatonina baixa dose (0.3-1mg) — só como sinal de horário, à mesma hora todos os dias. Não como sedativo.

NÃO COMPRES

Suplementos "sleep blend" com 8-10 ingredientes em micro-doses — marketing puro, evidência nenhuma.

Melatonina em doses altas (3-10mg) — supraphysiológica, contraproducente para o ritmo natural.

CBD para sono isolado — evidência inconsistente, custo elevado, regulamentação confusa.

Pulseiras anti-EMF, almofadas magnéticas, "biohacks" sem evidência publicada.

Apps de tracking de sono usadas como diagnóstico (Oura, Whoop, Apple Watch) — úteis como ferramenta de feedback geral, perigosas se levarem a obsessão (orthosomnia). Não substituem polissonografia para diagnóstico real.

AS FONTES QUE SUSTENTAM ISTO.

Este guia sintetiza investigação de neurociência circadiana e medicina do sono. Se queres aprofundar, estas são as referências primárias.

ANDREW HUBERMAN • HUBERMAN LAB

Master Your Sleep & Be More Alert When Awake · Toolkit for Sleep · Using Light to Optimize Health. hubermanlab.com

MATTHEW WALKER • NEUROCIENTISTA DO SONO, UC BERKELEY

Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams (livro, 2017). The Matt Walker Podcast. TED Talk "Sleep is your superpower".

SATCHIN PANDA • SALK INSTITUTE

The Circadian Code (livro, 2018). myCircadianClock.org. Investigação primária sobre time-restricted eating e luz.

SAMER HATTAR • NIH

Investigação sobre melanopsina e ipRGCs (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells). Entrevistas Huberman Lab #156.

RUSSELL FOSTER • OXFORD

Life Time: The New Science of the Body Clock (livro, 2022). Neurocientista circadiano.

AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS

Clinical Practice Guideline: Management of Chronic Insomnia in Adults (2016) — recomenda CBT-i como primeira linha antes de qualquer farmacologia.

CBT-I COACH

Aplicação gratuita desenvolvida pelo VA (US) + Stanford. Programa estruturado de 6 semanas baseado em terapia cognitivo-comportamental para insónia. Acesso gratuito iOS / Android.

SLEEP FOUNDATION • [SCIENCEOFSLEEP.ORG](https://scienceofsleep.org)

Resumos clínicos actualizados de investigação publicada. Recurso secundário, útil para verificação.

Nota clínica: este guia condensa investigação extensa num formato accionável, mas **não substitui consulta clínica individual**. Sintomas persistentes ou agravamento exigem investigação personalizada — sobretudo em perimenopausa, onde a sobreposição de eixos hormonais (HPA, tireoideu, gonadal) requer avaliação integrada.

— SOBRE • CATARINA VEIGA

QUEM ASSINA O QUE ACABASTE DE LER.

Catarina Veiga é praticante de medicina funcional integrativa com mais de duas décadas de experiência clínica em interpretação de análises funcionais, nutrição clínica, e saúde intestinal. Trabalhou com psicólogos e psiquiatras antes de aprofundar a fisiologia que sustenta a saúde mental.

Durante quatro anos esteve em Londres, com uma das startups europeias mais inovadoras em medicina funcional, na área do microbioma e como directora do Departamento de Educação para a Saúde e Literacia em Saúde. Acompanha actualmente mulheres em Portugal e internacionalmente.

A sua prática foca-se em *mulheres com sintomas persistentes e análises convencionais "normais"* — onde a fragmentação do sistema de saúde tradicional falha em integrar o que está ligado. Sintomas de perimenopausa, fadiga crónica, problemas de sono, ansiedade funcional e neurodivergência tardia compõem a maioria dos casos.

Este guia é uma síntese de:

- Mais de 200 consultas reais com mulheres em perimenopausa;
- Investigação clínica e neurocientífica de Huberman, Walker, Panda, Foster, Hattar;
- Frameworks de medicina funcional integrativa aplicados ao contexto português / europeu;
- Princípios de CBT-i (terapia cognitivo-comportamental para insónia) — a intervenção com mais evidência clínica para queixas de sono não-orgânicas.

Filosofia clínica: protocolo antes de medicação. Higiene antes de suplementação. Investigação antes de intervenção. Sistema antes de sintoma.

A medicina funcional não é alternativa.
É integrativa.

— FECHO

NÃO SÃO INSÓNIAS. É FALTA DE PROTOCOLO.

A maior parte do que as mulheres em perimenopausa chamam insónia é, na realidade, ausência de higiene de sono numa fase em que o corpo deixou de tolerar essa ausência. Antes de medicar, antes de suplementar, antes de procurar o próximo truque — instala a base.

Quatro a seis semanas de consistência rigorosa. É isso que separa um diagnóstico real de um diagnóstico apressado.

E se, depois disso, o problema persiste? Aí sim, tens informação clínica útil — e o terreno preparado para que qualquer intervenção subsequente (hormonal, suplementar, psicológica) funcione sobre uma base, em vez de num caos.

A higiene de sono é a *condição prévia*
de qualquer outra coisa que se faça pelo sono.

PRÓXIMO PASSO • CONSULTA FUNCIONAL INTEGRATIVA

Queres apoio para instalar este protocolo?

Trabalho com mulheres em perimenopausa para construir um plano funcional integrativo individualizado — análises completas (cortisol manhã, ritmo cortisol 4 amostras, perfil tireoideu, DHEA-S, perfil estrogénios, ferritina), suplementação adaptada, e acompanhamento clínico semanal durante 12 semanas. Marca uma consulta inicial em catarinaveiga.com ou responde directamente ao DM onde recebeste este guia.

© 2026 Catarina Veiga. Edição I. Uso individual — não redistribuir. Para licenciamento clínico ou institucional, contacto directo.